

설사(Diarrhea)

❖ 기본적 진단 계획

- ① 혈액검사 : CBC, electrolyte, TFT, 혈액 배양
- ② 대변검사 : 대변 배양, 대변 WBC
- ③ 영상검사 : 복부 X-ray, 복부초음파, 복부 CT, 대장내시경

❖ 치료 계획

수액 공급 및 전해질 교정(공통적)			
기능성	운동	갑상샘항진증 과민대장증후군 거짓막대장염	호르몬 안심시키기, 자극성 음식 회피 및 유제품 제한/loperamide 항생제 중단하고 vancomycin으로 변경
	삼투	젖당불내성	유당 회피
기질성	흡수	단장증후군	TPN(완전정맥영양), 지사제, Cholestyramine
	감염	식중독 급성 위장염(AGE)	수액 공급, 항생제(지사제 금기)
	기타	염증성 장질환(IBD) 결장암/직장암	입원, bed rest, sulfasalazine, mesalazine, steroid 수술, 방사선 치료, 항암제

❖ 환자 안내/생활 습관 교육

- ① 요리하거나 음식물을 먹기 전에는 반드시 손을 씻고, 음식물을 제대로 데워서 먹어야 함을 교육
- ② 탈수가 심한 경우 병원에서 수액 치료를 받고 충분한 휴식을 취하면 호전됨을 안내
- ③ 지사제의 남용은 좋지 못하므로 꼭 필요한 경우에만 사용할 것임을 강조
- ④ 영양 공급 충분히 하되, 카페인, 알코올, 유제품 피하기
- ⑤ 원인 물질이 있는 경우 원인 물질 회피
- ⑥ 기질적 질환(혈변, 심한 체중 감소)이 의심되는 경우 대장내시경의 필요성에 대해서 설명
- ⑦ 급성 설사의 경우 대부분 자연 호전
→ But, 3일 이상 지속, 고열(>38.9℃), 혈변, 심한 복통, 탈수 있으면 즉시 내원(응급)

❖ 소아 감별 진단 코멘트

변비

소아의 경우 변비의 90% 정도가 기능성 변비이며, 기질적 원인으로 선천성 거대결장을 의심해야 합니다. 이 둘을 감별하기 위해 DRE를 통해 딱딱한 변이 촉진되면 기능성 변비, 비어 있으면 선천성 거대결장을 의심해야 합니다.

선천성 거대결장의 경우 CPX에 직접적으로 출제되기에는 어려움이 있다고 판단합니다.

설사

소아에서도 설사는 성인에서와 마찬가지로 급성과 만성으로 구분되며, 급성 설사는 염증성과 비염증성으로 감별 진단합니다.

만성 설사라면 만성 비특이설사, 유당불내증, 알레르기 직장결장염 등을 감별해야 합니다.

이 세 가지 모두 CPX에 출제되기는 어렵다고 생각합니다.



keyword

배변 이상 증례의 경우 변의 양상(굵기, 색깔, 양, 냄새, 수양성/끈적임/기름기 여부 등)을 자세히 묻고, 내분비 질환(부신, 갑상샘 질환)을 감별하는 것을 잊지 맙니다.

변비의 경우 기질성/기능성 원인으로 나눠 감별하고, 설사의 경우 2주/4주 기간으로 급성/만성을 감별해 급성 설사는 감염성/비감염성, 만성 설사는 기능성/기질성 원인을 감별합니다.

신체 진찰 시 갑상샘 질환 등을 진단하기 위해 목 진찰하는 것과 탈수 평가를 위해 혀, 피부 긴장도를 진찰해야 합니다. 전해질 이상이 의심 시 이 또한 추가 검사로 평가해야 합니다.

변비 keyword

수분 섭취 정도, 식습관, 운동, 약물력을 잊지 말고 확인합니다.

잔변감, 질쪽으로 밀려나오는 느낌 등 증상을 호소하는 경우 직장류를 의심해 골반 내진을 시행합니다.

급성		장폐색	A/N/V, 수술, 타(tympanic)
		대장암	고령, 체중 감소, 혈변, DRE(혈변)
만성	기능성	기능성 변비	젊음, 평소 건강, 저섬유식, 수분 섭취 ↓
		IBS	설사와 번갈아, 배변 후 복통 호전
		약물	항고혈압, 항콜린, 철, 아편
	소화기	치핵/치열	휴지에 피
		직장류	잔변감, 골반 내진
		IBD	젊음, 체중 감소, D, 혈변, 복통
	내분비	hypoT	갑상샘 증상

설사 keyword

급성 설사의 경우 **최근에 먹은 음식을 반드시 확인**해 감염성 설사 원인을 감별합니다.

교육 : 변비약, 지사제 과다 사용의 위험성을 알리고 남용을 자제하도록 교육해야 합니다. 식습관, 운동 등 생활 습관 개선과 올바른 배변 습관을 교육하도록 합니다.

응급 상황 교육 : 설사량이 많아 두근거림, 어지럼, 호흡곤란 등 탈수 증상이 나타나는 경우 바로 내원을 해달라고 합니다.

급성		식중독	탈수, 발열, N/V, 복통, 특이 음식
		허혈성 대장염	고령, 급성 복통, 혈변, 기저 질환
만성	기능성	과민대장증후군	스트레스 악화, 배변 후 복통 호전
		젖당불내성	우유
		약물 유발	항생제, 변비약
	소화기	염증성 장질환	젊음, 체중 감소, 혈변, 심한 복통
		대장암	고령, 체중 감소, 변비, 혈변
		단장증후군	장절제
	내분비	TT	TT 증상

시험 관점 코멘트



황달의 경우 시간이 부족한 증례임으로 시간 배분에 주의해야 합니다.

가성 황달을 먼저 감별 후 간, 담체를 나누어서 접근하는 것이 중요한 감별 포인트입니다. 간독성을 일으키는 약물과 술을 피하는 것과 간염 예방접종을 교육하

는 것도 중요합니다.

민물계장/날 음식 섭취, 여행, 단체 생활, 위험한 성관계에 대한 것도 다른 소화기 항목과의 차별점이므로 잊지 말고 물어보세요. 음주력, 지방변, 복통, 당뇨병 병력 등은 체장염과 밀접한 관계가 있습니다. 몸은 노랗지만 공막이 하얀 경우에는 가성 황달을 의심해 볼 수 있습니다.

황달 증례는 물어 볼 것도 많고 원인을 찾기 어려운 경우가 많습니다. **실제 시험장에서 황달 증례가 나온다면 진단을 맞추는 것도 중요하지만 빼먹지 말고 꼼꼼히 문진을 하는 것이 더 필요할 것 같습니다.**

급성 간염의 경우 휴식, 영양 공급과 같은 보존적 치료로 증상이 호전될 수 있음을 환자에게 설명하고, 원인 감별을 위한 혈청학적 검사 및 영상검사가 필요함을 알려야 할 것입니다. 또한 A형 간염과 같은 법정 감염병이 발견되는 경우 국가에 신고해야 할 의무가 있음을 알려야 합니다.

ERCP의 경우 절대 익숙한 약자를 말하지 않고, 환자에게 “내시경역행담체관조영술”이라 풀어서 말하고, 교육에서 간단하게 설명하도록 합니다.

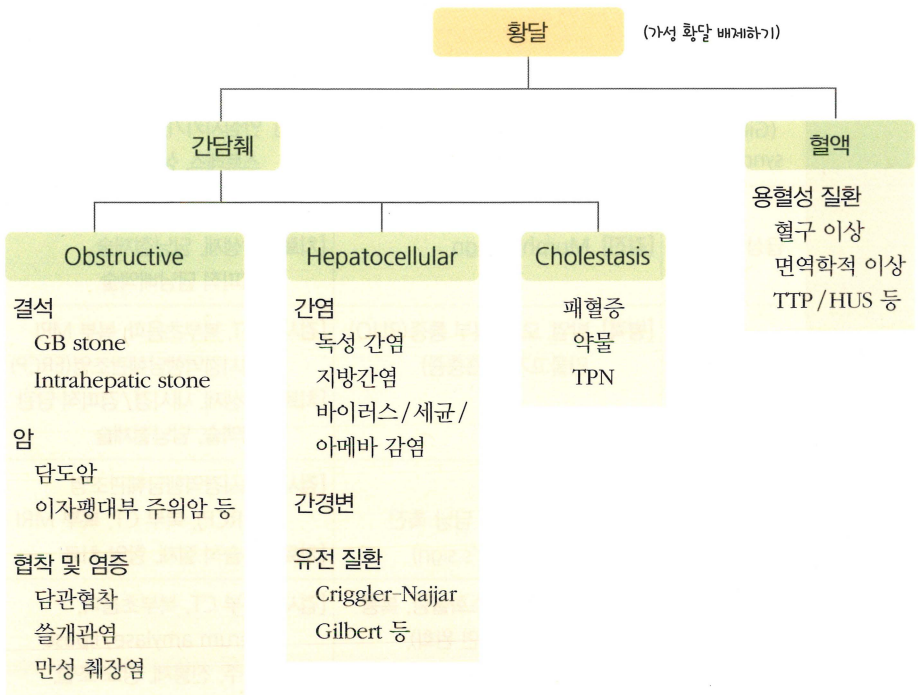
질병별 진단 / 치료 계획 정리

계통	질병	진단 키워드	검사/치료
간	급성 바이러스 간염★ (viral hepatitis)	[병력] 오염된 음식물 섭취, 여행력(A형), 위험한 성 접촉, 혈액 접촉(B형) [검진] 우상복부 압통, 간비대, 관절통, 근육통, 피로, 미열	[검사] LFT, anti-HAV IgM, HBsAg, anti-HBc IgM, anti-HCV [치료] 수액 정주/영양 공급, 간이식(전격 간부전)
	독성 간염★ (약물, 독)	[병력] 여러 약물, 건강식품, 한약	[검사] LFT [치료] 간이식, 원인 약물 복용 중단

간	알코올성 간염★ / 간경화증★ / 간암★	[병력] 토혈, 피로, 복수, 이전 간염 감염력, 술을 많이 마심, 체중 감소/RUQ pain(간암) [검진] 복부 비대, 복수, Spider angioma, Flapping tremor	[검사] LFT(PT, Bil, Alb), 복부 CT, 혈액검사(albumin, PT) [치료] 간이식, 락툴로스, 복수 조절 (Spironolactone, Furosemide) (알코올성) 금주, 영양 공급, Glucocorticoid (간경화증) 원인 질환 치료, 합병증 치료, 간이식, 합병증 없으면 6개월마다 초음파 (복수) 저염식, 이뇨제 (간암) 간절제술, 경피적 에탄올 주입술, 항암 치료
	윌슨병 (Wilson's disease)	[병력] 어린 나이 황달, 신경학적 이상, 가족력 [검진] K-F ring이 눈에서 관찰	[검사] 혈중 셀룰로플라스민, 24시간 소변 구리 배출 [치료] 트리엔틴(1차), 페니실라민(2차), 간이식(3차), 구리 섭취 제한(버섯, 초콜릿, 조개, 호두, 밤, 갑각류, 건조과일, 간)
	길버트 증후군★ (Gilbert's syndrome)	[병력] 가족성 황달, 스트레스, 감염, 운동, 피로, 금식 후 심해짐 [검진] 별다른 이상 소견 없음	[검사] LFT [치료] 안심시키기, 유발 요인(금식, 스트레스, 심한 운동, 과음) 관리
담체	급성 담낭염	[병력] 발열, 오한, 복부 통증(RUQ) [검진] Murphy's sign	[검사] LFT, 복부초음파, 복부 CT [치료] 항생제, 담낭절제술, 경피적 담낭배액술
	담관염★	[병력] 발열, 오한, 복부 통증(RUQ), 민물고기(간흡충증)	[검사] LFT, 복부초음파, 복부 MRI 내시경역행담췌관조영(ERCP) [치료] 항생제, 내시경/경피적 담관 배액술, 담낭절제술
	담관암★ / 췌두부암★	[병력] 체중 감소 [검진] RUQ 무통성 담낭 촉진 (Courvoisier's sign)	[검사] 내시경역행담췌관조영 (ERCP), 복부 CT, 복부 MRI [치료] 수술적 절제, 항암 치료
	만성 췌장염	[병력] 음주, 담석, 소화불량, 복통 (앞으로 속이면 완화), 지방변, 당뇨병 병력 [검진] 특이 사항 없음	[검사] 복부 CT, 복부초음파, serum amylase/lipase [치료] 금주, 진통제, 당뇨 조절, 췌장 효소 공급

혈액	용혈성 질환	[병력] 호흡곤란, 어지럼, 쉽게 멍들, 빈혈력 → 수혈력 물어보기 [검진] 결막 창백, 비장 종대	[검사] CBC, LFT, 말초혈액도말검사 [치료] 비장절제술, 스테로이드 등
기타	감염 단핵구증 (infectious mononucleosis)	[병력] 인후통, 전신의 림프절 종대 [검진] 인두부 발적, 간비 종대	[검사] 이종친화항체검사, 엡스타인-바바이러스 특이항체 검사, LFT [치료] 경과 관찰, 대증 치료 (Acetaminophen, NSAID)
	가성 황달	[병력] 얼굴과 손만 노래짐 [검진] 공막 황달 없음	[검사] LFT [치료] 없음

증례별 알고리즘



STEP 1 병력 취취

O	언제부터 몸이 노래지기 시작하셨나요?
L	어디어디 노란가요? → 눈, 양손, 전신 처음 노래진 부위가 어디죠? 노란 부위가 점점 퍼지기 시작했나요? (공막에서 시작해서 양 손바닥, 가슴으로 퍼짐)
D	-
Co	점점 심해지나요?
Ex	이전에도 이런 증상이 있으셨나요?/당시 치료를 받았었나요?
C	정확히 어떤 노란색인지?/녹색에 가까운 노란색인가요? 최근에 녹황색 채소(당근, 호박, 오렌지)를 많이 드셨나요?
A	[전신] 발열/오한/피로/체중 변화/부종이 있나요? 관절통/근육통이 있었나요? (viral, toxic hepatitis) [탈수] 어지럼증/호흡곤란/소변량 감소가 있었나요? [출혈 경향] 쉽게 멍이 드나요?/코피나 잇몸에 피가 쉽게 나나요? [소화기] 식욕 저하/구역/구토/설사/변비/토혈/흑색변/혈변/지방변/복통/소화불량 이 있나요? [황달 증상] 배가 부풀어 오르나요? (복수)/소변색이 진해졌나요? 대변색이 변했나요? (회색변)/몸이 가려운가요? 암기법 복수극으로 소진된 대회를 가려고? 설명 복수(복수)극으로 소진(소변색 진해짐)된 대회(대변색 회색)를 가려고 (가려움)?
F	술, 약, 스트레스, 금식, 운동 시 노래지는게 더 심한가요? (길버트 증후군) 최근에 감기 증상이 있으셨나요? (길버트 증후군) 최근에 여행 다녀오신 적이 있으셨나요? (A형 간염) 평소 드시지 않던 음식을 드셨나요?/최근에 날 것 섭취한 적 있나요? 생선회, 민물고기, 해산물 먹은 적 있나요? (A형 간염, 기생충) 실례지만 성관계 상대가 여러 명인가요? (B형 간염)
E	이전에 건강 검진 받은 적 있나요?/A형, B형 간염 예방접종은 하셨나요? 이전에 수혈 받은 적 있나요?/어떤 이유로 수혈을 받았나요? (용혈성 질환)
외	이전에 복부 수술 받으신 적 있나요?/이전에 복부를 다친 적이 있나요?

과	이전에 진단받은 병이 있나요?/간질환, 고혈압, 당뇨병을 앓고 계신가요?
약	복용 중인 약물이 있나요? 예 건강보조식품, 한약, 약초 등
사	술은 드시나요?/흡연은 하시나요?/직업이 어떻게 되시나요? [식습관] 평소 식습관이 어떻게 되시나요?
가	가족 중 비슷한 증상 있는 분 있나요?/가족 중 간질환, 암, 용혈 질환 등을 앓으신 분 있나요?
여	생리량 변화 등
P/E	이제 신체 진찰을 하도록 할텐데요, 괜찮으신가요? 오늘 측정한 활력 징후는 정상입니다(이상 소견이 있는 경우 언급해 주기). [앉아서] 1. 눈*: 결막(빈혈), 공막(황달) 2. 입 : 혀(탈수) 3. 목 : 경부 림프절 촉진(암, 감염성 질환) 4. 흉부 : 시진(spider angioma) 5. 손(피부)* : 피부 긴장도, Palmar erythema, Flapping tremor* ☞ 환자의 손등이 위로 가게 팔을 앞으로 편 후 손등을 뒤로 90° 젖히게 하고, 의사가 환자의 손등 쪽으로 밀어 떨림이 있는지 확인합니다. 6. 하지 : 부종 [누워서] 7. 복부(간)* [시진] 수술 흔적/복부 팽만/Spider angioma/Caput medusae [청진] 차가우실 수 있어요./5구역, 3초씩 [타진] 타진 4군데/간, 비장 타진/복수(shifting dullness) ☞ 복수 신체 진찰을 참고하여 정확하게 복수 여부를 확인하는 진찰을 하도록 합니다. [촉진] Superficial 4군데, Deep 4군데, 통증 있으면 반동 압통도/간, 비장 촉진 [특이검사]* Murphy, courvoisier(무통성 담낭이 만져짐) ☞ Courvoisier 검사를 하며, "담낭이 만져지지 않는 것 확인했습니다"라고 언급하면 좋습니다. → 협조해 주셔서 감사합니다. 불편한 것은 없으신가요?

STEP 2 환자 교육

공감	눈과 얼굴이 노래져서 많이 놀라셨을 것 같습니다.
추정 진단	지금까지의 문진과 신체 검진 소견을 종합해 보았을 때 000로 미루어 보아, 양00님의 경우 급성 바이러스 간염이 의심됩니다.
감별 진단	하지만 황달의 원인으로 다른 종류의 간염이나 담도 질환을 완전히 배제할 수 없습니다.
검사	따라서 정확한 진단을 위해 간기능검사, 간초음파, 간염 바이러스 검사가 필요할 것으로 보입니다. 괜찮으신가요?
치료	만약 급성 바이러스 간염이 확진되면 환자분이 불편해하시는 증상에 맞게 치료가 이루어질 것입니다. 황달로 인한 가려움 때문에 힘드시다면 담즙을 배출해주는 콜레스티라민을 처방해 드리겠습니다. 또 종류에 따라 항바이러스제로 치료 가능한 경우가 있습니다.
예후	지금부터 잘 치료를 받으시면 호전되실 수 있습니다. 증상이 있을 때 병원에 잘 오셨습니다.
교육	[생활 습관 개선] 정확한 진단이 되기 전까지 우선 간독성을 일으키는 약물(한약이나 약초 다린 물)은 피하는 게 좋고, 술은 먹지 않는 것이 치료에 도움이 됩니다. [간염 예방접종의 필요성] B형 간염 예방접종은 하셨다고 하셨는데, A형 간염 예방주사도 추가적으로 접종하는 것이 필요합니다.
질문	마지막으로 혹시 궁금한 점이 있으신가요?

❖ 기본적 진단 계획

- ① 혈액검사 : LFT(AST, ALT, ALP, GGT, PT, Alb, Protein, bilirubin), CBC
- ② Viral marker : anti-HAV IgM, HBsAg, anti-HBc IgM, anti-HCV
- ③ 영상검사 : 간초음파, 복부 CT, 복부 MRI

❖ 치료 계획

- ① 안정, 수액요법, 항바이러스제
- ② A형 간염 : 입원 치료, 항바이러스제는 불필요(회복 속도 높이거나 만성화 줄이지 ×)

❖ 환자 안내/생활 습관 교육

- ① 황달로 인한 소양감을 줄이기 위해서 담즙을 배출하는 콜레스티라민이라는 약을 처방해주어 증상을 완화할 수 있다.
- ② 간독성을 일으키는 약물, 음주를 피하고, 간염 예방접종의 중요성 강조★
 - A형 간염 : (음식 접촉) 보존적 치료로 완치 가능, 한 번 치료 시 재발 ×
 - B, C형 간염 : (피 접촉) 만성화 가능, 간경화증이나 간암으로 진행 가능

 약/한약/건강 보조식품을 함부로 먹지 않도록 교육합니다. 만약 간염의 경우 법정 감염병으로 국가에 신고할 의무가 있음을 교육합니다.
- ③ 황달 원인에는 감염성 질환, 담도 폐쇄성 질환, 용혈성 질환 등 다양한 원인 있을 수 있다는 것 교육하고, 추가적 검사 및 원인 질환에 대한 치료 필요함을 말한다.
- ④ A형 간염 및 B형 간염 예방접종 여부를 확인 후 예방접종도 오늘 내원하였으니 하고 가시라고 권고하기
- ⑤ 간은 충분히 쉬면 좋아지는 장기라고 안심시키기
- ⑥ 응급 처치가 필요한 담관염이 의심되는 경우 입원 및 항생제, 담관배액술 등의 치료가 필요할 수 있음을 교육하기



keyword

시간 배분 주의하기

가성 황달을 먼저 감별한 후, 간, 담체를 나누어 감별하기

날 음식 섭취, 여행력, 단체 생활, 위험한 성관계 등 빼먹지 말고 꼼꼼히 문진하기

간독성을 유발하는 약물, 술 회피 교육하기

간염 예방접종 교육하기